

Interstitial Cystitis / Bladder Pain Syndrome

Impormasyon para sa Pasyente · Pangmatagalang sakit sa pantog na hindi sanhi ng impeksiyon

WARWIKI

Ang interstitial cystitis, na tinatawag ding bladder pain syndrome (IC/BPS), ay isang pangmatagalang kondisyon na may **sakit, presyon, o diskomfort sa pantog o pelvis**, kasama ang madalas o biglaang pangangailangang umihi — **nang walang impeksiyong nagdudulot nito**. Ang diskomfort ay kadalasang lumalakas habang nagpupuno ang pantog at gumagaan pagkatapos umihi. Maaari itong kontrolin nang maayos, kahit walang isang hakbang na lunas.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang IC/BPS ay hindi impeksiyon at hindi nakakahawa. Nagkakaiba-iba ang sintomas sa bawat tao at madalas na may **pagsiklab ng sintomas** (flares — panahon ng paglala) at mahinang panahon. Karaniwang katangian:

- Sakit, presyon, o diskomfort sa pantog o pelvis
- Madalas at/o biglaang pangangailangang umihi, araw at gabi
- Diskomfort na **lumalala habang nagpupuno ang pantog** at gumagaan pagkatapos umihi
- Mga pagsiklab na maaaring bunga ng ilang pagkain, stress, o regla

Mga Sanhi

Hindi pa ganap na nalalaman ang eksaktong sanhi. Malamang na kaugnay ito ng sensitibo o nairitang lining ng pantog, labis na sensitibong nerves, at (madalas) **mahigpit at overactive na pelvic floor**. Dahil maraming dahilan, karaniwang pinagsasama ang ilang paraan ng paggamot.

MGA TERMINO

IC/BPS

Interstitial cystitis / bladder pain syndrome — sakit sa pantog at biglaang pangangailangang umihi, hindi sanhi ng impeksiyon.

Flare

Pagsiklab ng sintomas, madalas na dahil sa pagkain o stress.

Diagnosis of exclusion

Dina-diagnose pagkatapos maalis ang ibang sanhi (tulad ng impeksiyon).

Pelvic-floor therapy

Physical therapy para paluwagan ang mahigpit na muscles ng pelvis.

Bladder instillation

Pampalambot na gamot na inilalagay sa pantog sa pamamagitan ng manipis na catheter.

Hunner lesion

Tiyak na patch sa dingding ng pantog na makikita sa ilang tao; maaaring gamutin nang direkta.

Cystoscopy

Pagtingin sa loob ng pantog gamit ang manipis na camera.

MAWAWALA BA ITO? Ang IC/BPS ay karaniwang pangmatagalang kondisyon, ngunit karamihan ay nakakakuha ng tunay na ginhawa sa pamamagitan ng pagsasama ng mga paggamot at pag-alam sa mga trigger. Ang layunin ay mas kaunti at mas mahinang pagsiklab at normal na pang-araw-araw na buhay — kadalasang kailangan ng ilang pagsubok bago mahanap ang tamang halo, kaya maging matiyaga sa proseso.

Paano Ito Nasusuri

Walang isang solong pagsusuri. Ginagawa ng inyong care team ang diagnosis batay sa inyong mga sintomas pagkatapos maalis ang ibang sanhi:

- Isang **pagsusuri sa ihi** para maalis ang posibilidad ng impeksiyon o dugo sa ihi
- Kasaysayan ng sintomas at **bladder diary** (talaan ng pag-ihing)
- Minsan ay **cystoscopy** para hanapin ang Hunner lesion

Paano Ito Ginagamot (Hakbang-Hakbang)

- 1 **Self-care** — alamin ang inyong mga **trigger na pagkain**, pamahalaan ang stress at tulog, at gumamit ng mahinang bladder training.
- 2 **Pelvic-floor physical therapy** — para paluwagan ang mahigpit na muscles (paalala: malakas na Kegel exercises ay maaaring magpalala).
- 3 **Mga gamot** — oral na opsyon, at pampalambot na **bladder instillations**.
- 4 **Naka-target at advanced na pangangalaga** — paggamot sa Hunner lesion, o nerve stimulation sa matibay na kaso.

Pamumuhay Dito

- Karaniwang trigger: **kape, tsaa, alak, katas ng prutas (citrus), kamatis, at maanghang na pagkain** — subukang alisin, pagkatapos ay ibalik nang isa-isa para malaman ang sa inyo.
- Magkaroon ng **flare plan** (pahinga, init, dagdag na tubig, malambot na pagkain).
- Nagpapalala ang stress at mahigpit na pelvic floor sa kondisyon — mahinang ehersisyo at relaxation ay nakatutulong.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat, panginginig, o sakit sa likod/tagiliran (posibleng impeksiyon)
- **Bagong dugo sa ihi**
- Pagsiklab na hindi makontrol, o hindi kayo makapagihing

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang IC/BPS ay sakit sa pantog/pelvis na may biglaang pangangailangang umihi na **hindi** impeksiyon — pangmatagalan, ngunit lubos na mapamamahalaan.
2. Pinagsasama ang paggamot: self-care at trigger control, pelvic-floor therapy, mga gamot at instillations, at naka-target na pangangalaga para sa tiyak na natuklasan.
3. Alamin ang inyong mga trigger sa pagkain at stress at magkaroon ng flare plan. Ang bagong dugo sa ihi, lagnat, o sakit sa tagiliran ay dapat suriin.